

Cervicalgia

Pablo Muñoz Muñoz^a, Alejandra Tejedor Molledo^b, David de la Rosa Ruiz^c, María del Pino Calderín Morales^d y Marina Jaquete Pastor^e

^aR4 Medicina Familiar y Comunitaria. C. S. Las Ciudades. Getafe. Madrid. España.

^bR3 Medicina Familiar y Comunitaria. C. S. Las Ciudades. Getafe. Madrid. España.

^cEspecialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los Rosales. Madrid. España.

^dEspecialista en Medicina Familiar y Comunitaria. C. S. Las Ciudades. Getafe. Madrid. España.

^eF.E.A. Urgencias Hospitalarias. Hospital Dr. José Molina Orosa. Lanzarote. España.

*Correo electrónico: davidmalaguno@hotmail.com

Puntos para una lectura rápida

- La cervicalgia, es un importante problema de salud a nivel mundial, con un peso relativo mayor en los países desarrollados. Tiene un elevado impacto personal con afectación de la calidad de vida y la funcionalidad y también un elevado coste económico debido tanto a costes directos como a los indirectos por pérdida de productividad laboral.
- Las pruebas complementarias estarán indicadas en el caso de que el paciente presente alguno de los signos de alarma referidos anteriormente. En la mayoría de los pacientes, una radiografía cervical será la primera prueba.
- Las pruebas complementarias estarán indicadas en el caso de que el paciente presente algún signo de alarma. En la mayoría de los pacientes, una radiografía cervical será la primera prueba.
- Los objetivos del tratamiento serán minimizar el dolor, aliviar el espasmo muscular y reestablecer una curva cervical óptima; con la finalidad de recuperar la funcionalidad plena.
- La mayoría de los dolores agudos, de leves a moderados, se resuelven aproximadamente en 3 semanas con medidas conservadoras. Un tratamiento inicial dirigido a la causa no ha demostrado mayor beneficio al compararlo con un tratamiento sintomático no específico.
- El tratamiento debería comenzar facilitando información al paciente, trabajando en corregir su postura, prescribir una rutina de ejercicios y ayuda farmacológica para control del dolor, facilitando la adherencia al tratamiento físico.
- Si no hay contraindicación: los AINE son la primera línea de tratamiento ajustando su prescripción a la correcta evaluación de los riesgos cardiovascular, gastrointestinal y renal. Deben indicarse durante el menor tiempo posible a la dosis mínima eficaz.
- Los fármacos coanalgésicos (antidepresivos y antiepilépticos) se recomiendan en caso de persistencia de la sintomatología. Su elección depende de los síntomas asociados y comorbilidad.
- Los fármacos antiepilépticos como gabapentina o pregabalina se usan con frecuencia, sin embargo, esta práctica no presenta evidencia suficiente para recomendarlo de manera rutinaria.
- La mayoría de la evidencia actual nos ha permitido poder descartar intervenciones innecesarias o incluso perjudiciales como el sobreuso de las pruebas de imagen o el uso indiscriminado de opioides y antiepilépticos.

Palabras clave: Cervicalgia • Dolor de cuello • Radiculopatía.

¿Cómo se define el problema?

El dolor cervical o cervicalgia se define como aquel dolor que se localiza entre el occipucio y la primera vértebra torácica, con o sin irradiación a las extremidades superiores y de duración superior a un día^{1,2}. Desde un punto de vista temporal, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP)

considera como dolor crónico³ aquel que dura más de 3 meses, por lo que en relación con la cervicalgia podemos diferenciar:

- Aguda: duración menor de 3 meses.
- Crónica: duración mayor de 3 meses con afectación de la calidad de vida.

Según sus características, podemos clasificar el dolor en mecánico, radicular, inflamatorio o referido (tabla 1)⁴.

TABLA 1. Clasificación de los tipos de dolor			
Dolor mecánico	Dolor radicular	Dolor inflamatorio	Dolor referido y visceral
No constante Empeora con el movimiento Mejora con reposo No despierta	Continuo Lacerante Síntomas sensitivos Irradiado por territorio nervioso	Constante Empeora con el movimiento No mejora en reposo Despierta	Mal localizado No relacionado con el movimiento Sordo
Modificada de Pérez Cajaraville et al. ⁴ .			

TABLA 2. Causa de cervicalgia según su origen	
Causas musculoesqueléticas	Esguince o distensión cervical Latigazo cervical Dolor discogénico cervical Artrosis facetaria Dolor cervical miofascial Hiperostosis esquelética difusa
Radiculopatía/mielopatía	Radiculopatía cervical Mielopatía cervical espondilótica Osificación del ligamento longitudinal posterior
Enfermedades reumatológicas	Polimialgia reumática Arteritis de células gigantes Fibromialgia Síndrome de la salida torácica
Condiciones neurológicas	Cefalea tensional Distonía cervical Malformación de Chiari
Otras causas	Dolor de hombro referido Enfermedad coronaria Infección (osteomielitis, discitis, absceso faríngeo, meningitis) Obstrucción esofágica Enfermedad del tracto biliar y hepática Tumor pulmonar apical Disección carotídea o vertebral
Fuente: Pérez Cajaraville et al. ⁴ .	

Esto puede ayudarnos a clasificar las causas de dolor cervical (tabla 2)^{5,6}:

Musculoesquelético

- Distensión cervical: dolor y rigidez en cuello y hombros , que puede originarse por malas posturas, malos hábitos de sueño, estrés, etc., pudiendo existir antecedentes de mecanismos de flexoextensión accidentales, o lesión de la musculatura paraespinal.
- Lesión por latigazo cervical: secundario a un mecanismo de flexoextensión con mecanismos de aceleración-deceleración brusca. Generalmente se manifiesta como dolor intenso con rigidez de manera inmediata o días después a la lesión.
- Síndrome de dolor miofascial: es una causa frecuente de cervicalgia crónica, con dolor localizado a nivel profundo, asociando alteraciones sensitivas tipo ardor, escozor y en ocasiones presencia de puntos gatillo.

- Espondilosis cervical: existen cambios degenerativos vertebrales, tipo osteofitos que pueden dar lugar a radiculopatía. No suele existir una correlación directa entre la clínica y los hallazgos en pruebas de imagen. La artrosis facetaria cursa con dolor cervical que empeora a la palpación de articulaciones cigoapofisarias y que se puede irradiar a hombros y zona periescapular. Asocia además rigidez con limitación para extensión y rotación del cuello.
- Dolor discogénico cervical: puede deberse al mantenimiento de una postura de manera prolongada (escribir, uso del ordenador, leer, conducir, etc.). Cursa con dolor, rigidez del cuello y en ocasiones afectación de las extremidades superiores.

Inflamatorio

Sospechar ante un dolor que empeora con el reposo, y por las noches. Es importante evaluar otra sintomatología acompañante posible como afectación de articulaciones sacroilíacas, lesiones dérmicas, afectación articular extraxial, etc., que nos puedan indicar la presencia de patología reumática.

Infeccioso

Clínicamente se puede presentar de forma brusca o progresiva, puede acompañarse de fiebre, escalofríos y dolor de características inflamatorias. Así mismo puede asociar déficits neurológicos por compresión medular o radicular. Puede ser secundario a abscesos epidurales, paraespinales, osteomielitis o discitis.

Tumoral

Sospechar ante un dolor cervical inflamatorio progresivo, independiente de la actividad física asociado a síntomas generales y pérdida de peso y en ocasiones puede empeorar por la noche aunque no siempre. Puede asociar radiculopatía secundaria a compresión

Neuropático

Por afectación de la raíz (radiculopatía): puede desencadenarse por múltiples causas, como cambios degenerativos con estenosis del canal, hernias discales, compresión por tumores, infecciones que como resultado comprometen la integridad de la raíz nerviosa. Pueden manifestarse como dolor descrito como calambre o quemazón, acompañado de alteraciones neurológicas motoras y sensitivas según la afectación.

Por afectación medular (mielopatía): suele deberse a cambios degenerativos que condicionan el estrechamiento del canal medular. Además del dolor, el paciente presenta clínica neurológica severa y progresiva siendo fundamental identificarla de forma precoz para poder realizar un tratamiento dirigido. Puede presentarse como debilidad de miembros superiores, hasta afectación de miembros inferiores y de la marcha, así como pérdida del control de esfínteres o disfunción sexual.

Otras causas

Traumático

Es muy importante hacer una buena anamnesis y exploración ya que la historia de antecedente traumático no siempre puede ser evidente (paciente con deterioro cognitivo, inconsciente, etc.) y a veces puede no ser la causa del dolor, necesitando frecuentemente pruebas de imagen si se objetiva alteración neurológica u otros signos de alarma.

Dolor referido

Es aquel dolor que el paciente localiza en región cervical y sin embargo con las características clínicas y exploración determinamos que no se origina en dicha zona. Existen múltiples causas que pueden originarlo y es necesario un contexto clínico para poder determinar su origen (angina de pecho o infarto agudo de miocardio; disección arterial (vertebral, carótida, aorta, etc.); neumotórax, bullas, pleuritis, tumor de pancoast; omalgia por rotura del manguito de los rotadores, capsulitis adhesiva; patología esofágica, etc.)

Malformaciones congénitas

Entre ellas a destacar la malformación de Chiari que puede dar cefalea y cervicalgia y asociar alteraciones neurológicas por compresión en tronco encefálico y médula. También la

siringomielia, que puede ser secundaria a la malformación anterior, es lentamente progresiva y suele ser indolora, acompañándose de debilidad de miembros superiores y, disminución de sensibilidad termoalgésica.

¿Cuál es la relevancia del problema en atención primaria?

La cervicalgia, es un importante problema de salud a nivel mundial, con un peso relativo mayor en los países desarrollados. Tiene un elevado impacto personal con afectación de la calidad de vida y la funcionalidad y también un elevado coste económico debido tanto a costes directos como a los indirectos por pérdida de productividad laboral. En España un 28,9% (IC95%: 27,6-30,2) de los pacientes refieren haber consultado por problemas osteomusculares⁷ y la prevalencia estimada de artrosis cervical es del 10,10 (IC al 95%: 9,07-11,24)⁸. En Estados Unidos, el dolor lumbar y cervical suponen la tercera causa de gasto en salud, tanto por atención directa como por pérdida de productividad, por detrás de la diabetes mellitus y la cardiopatía isquémica⁹. En España, la cervicalgia es una de las principales causas de incapacidad temporal con niveles en ascenso, pasando de la 8ª causa en 2008 a la 3ª en 2015¹⁰ (fig. 1).

Según los datos recogidos en los informes nacionales de salud de 2017 y 2018 la cervicalgia se encuentra entre los 5 problemas de salud más frecuentes en España^{11,12}. Es además un importante factor de discapacidad en los países desarrollados, llegando a ocupar el cuarto lugar más alto en términos de discapacidad según lo medido por años vividos con discapacidad (YLD) presentando una tendencia temporal ascendente¹³. Es además un factor frecuente de dolor crónico, la mayoría de los pacientes con dolor cervical agudo se resolverán en menos de dos meses, sin embargo, hasta un 50%

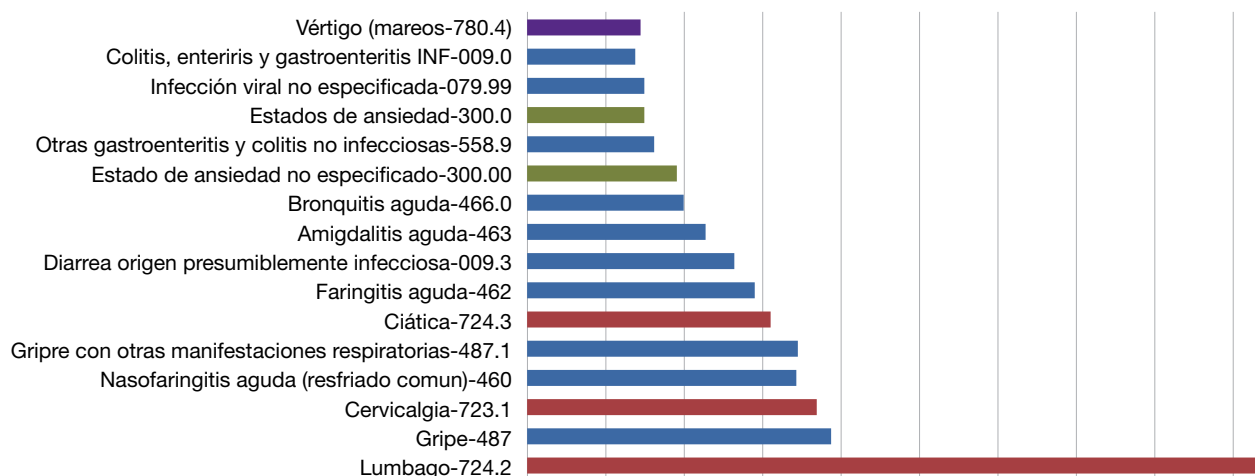


Figura 1. Causas de incapacidad temporal en 2015, extraída de Vicente Pardo et al.¹⁰ o extraída de Vicente Pardo JM. Med Segur Trab. 2018; 64(251):131-60.

TABLA 3. Factores de mal pronóstico y riesgo de cronicidad en el paciente con cervicalgia		
Factores asociados con mayor riesgo de cronicidad en el paciente con cervicalgia		
• El sexo femenino • La edad avanzada • La patología psicosocial coexistente • Los síntomas radiculares • Baja satisfacción laboral • Otras enfermedades reumatológicas o afectación de espalda concomitantes • Catastrofismo • Mala salud auto percibida • Sedentarismo • Cefalea • Tabaquismo • Trauma o lesión anterior del cuello • Dolor lumbar concomitante asociado • Irradiación del dolor • Imposibilidad de reposo o descanso nocturno • Episodios recurrentes de cervicalgia previos		
Fuente: Cohen ¹⁴ .		

TABLA 4. Datos de alarma en dolor cervical atraumático		
Signo	Importancia	Actuación y pruebas
Debilidad de miembros inferiores, problemas de la marcha o coordinación. Incontinencia o disfunción esfinteriana	Sugiere una posible compresión del canal cervical o mielopatía	Requiere valoración urgente mediante RM y valoración quirúrgica
Calambres agudos y/o parestesias descendentes que ocurren a la flexión anterior del cuello o al estornudar (signo de Lhermitte)	Sugiere compresión del canal cervical por herniación de disco o espondilistesis. Alternativamente puede ser signos de patología intramedular como esclerosis múltiple	Requiere valoración urgente mediante RM, o TAC cuando la anterior no esté disponible
Cervicalgia asociada a fiebre	Nos ha de obligar a descartar una infección en la zona	En caso de que se sospeche de infección en la zona requiere valoración urgente. Analítica RFA Rx +/- RM
Cervicalgia con pérdida de peso inexplicable por otras causas o historia de cáncer	Nos obliga a pensar en posibilidad de malignidad	Requiere de una valoración preferente para descarte de malignidad. Analítica con RFA, Rx +/- TAC o RM
Dolor cervical asociado con cefalea, dolor en cintura o hombros de forma bilateral o síntomas visuales en una persona mayor	Sugiere posibilidad de enfermedades reumáticas como polimialgia reumática o arteritis de la temporal	Requiere de una valoración preferente con analítica; solicitando marcadores inflamatorios
Dolor cervical anterior	No es un dolor típico para causas espinales o musculoesqueléticas y nos tiene que hacer pensar en dolores referidos o irradiados como angina, patología biliar, esófago o tiroides, así como tumores de pulmón apicales	Requiere una anamnesis y exploración exhaustiva para centrar la sospecha clínica
Adaptada de Pérez Cajaraville et al. ⁴ y Zacharia et al. ⁵ . RFA: reactantes de fase aguda; RM: resonancia magnética; RX: radiología simple; TAC: tomografía axial computerizada.		

pueden tener recurrencias o persistencia del dolor más allá de un año¹⁴. En la tabla 3 se describen los factores de mal pronóstico y riesgo de cronicidad.

El dolor cervical es por tanto un frecuente motivo de consulta con cifras de prevalencia ascendente, un impacto económico elevado y un elevado riesgo de cronificación, lo que condiciona un impacto en la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes, requiriendo un adecuado abordaje individualizado, multimodal y multidisciplinar.

¿Cuáles son las claves para el diagnóstico?⁴⁻⁶

Las pruebas complementarias estarán indicadas en el caso de que el paciente presente alguno de los signos de alarma referidos anteriormente (tabla 4).

En la mayoría de los pacientes, una radiografía cervical será la primera prueba. Aunque no es el objetivo principal de este artículo, recordar que, ante un traumatismo cervical de

alta intensidad, los pacientes deben de ser estabilizados hemodinámicamente y su cuello inmovilizado con collar rígido hasta ser trasladados para atención urgente.

Una vez estos han sido descartados, establecer una etiología específica puede resultar complejo y de menor relevancia, ya que el tratamiento se centra en los factores desencadenantes, características individuales del paciente y respuesta terapéutica más que en el diagnóstico específico. La mayoría de los pacientes con dolor cervical atraumático sin datos de alarma (tabla 4) no van a requerir pruebas de imagen.

Además de descartar síntomas de alarma, habrá que realizar una anamnesis para caracterización del dolor: inicio, duración, evolución, irradiación, características, intensidad, síntomas asociados.

En la exploración nos centraremos en el rango de movimiento, palpación del músculo trapecio y paraspinales, evaluación neurológica y de los miembros superiores; así como maniobras de provocación en caso de que el paciente presente síntomas radicales (signo de Lhermitte) (tabla 4).

Pruebas complementarias⁴⁻⁶

Las pruebas complementarias estarán indicadas en el caso de que el paciente presente alguno de los signos de alarma referidos anteriormente (tabla 4).

En la mayoría de los pacientes, una radiografía cervical será la primera prueba. El dolor moderado-severo, persistente (> 6 semanas) que afecta al descanso nocturno o limita las actividades diarias o laborales es susceptible de realización de pruebas complementarias, siendo la radiografía la prueba inicial. Si se detectan alteraciones, hallazgos distintos a las degenerativos (erosión de las facies articulares y edema de tejido blando, que podría corresponder con discitis/osteomielitis; destrucción ósea, con sospecha de metástasis; o remodelación ósea, con sospecha de malignidad...), se debería solicitar una resonancia magnética (RM).

Si existe sospecha de patología potencialmente severa (infección, malignidad, déficits neurológicos serios o compresión nerviosa) la RM y las pruebas de laboratorio deben solicitarse acorde a la sospecha. Si la RM está contraindicada o no disponible, un TC con contraste sería una alternativa aceptable.

En ausencia de datos de alarma (tabla 4), las pruebas de imagen no son necesarias en pacientes con dolor agudo leve-moderado o dolor crónico que no limita o interrumpe las actividades diarias, que no afecta a su trabajo y es fácilmente ignorado si el paciente no se focaliza en el dolor. Los pacientes que han sufrido un trauma cervical de baja intensidad (latigazo cervical) no suelen requerir pruebas de imagen. El TAC cervical urgente es la prueba de elección ante traumas de alta intensidad.

La radiografía cervical consistirá generalmente en las posiciones posteroanterior y lateral. En la visión lateral (fig. 2)

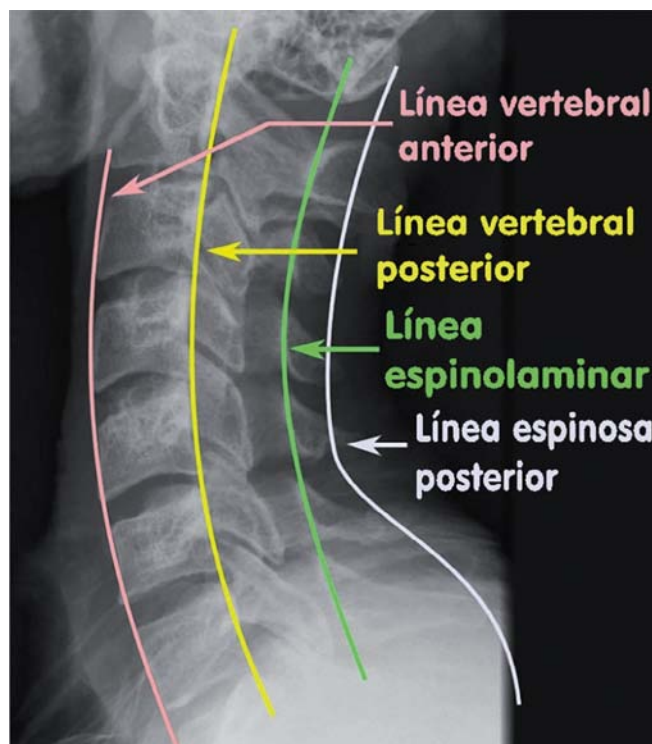


Figura 2. Radiografía cervical lateral normal donde se pueden observar las líneas espinales. Extraída de De RumierK - CC BY-SA 4.0, disponible en <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114944261>.

podemos observar el alineamiento vertebral; la curva lordótica cervical (con convexidad hacia anterior) podría estar rectificadas en una posición más recta o incluso inversa en dolores cervicales severos. La visión lateral también nos sirve para observar signos de osteoartritis en las facies articulares, articulaciones paravertebrales o adelgazamiento del disco. Mientras que en la visión anteroposterior nos fijamos en la posición vertical de las vértebras y la ausencia de rotación de las apófisis espinosas. Otras proyecciones no son necesarias normalmente, a excepción odontoidea (con la boca abierta) que nos ayuda a valorar la articulación atlantoaxial y que debe solicitarse en paciente con trauma cervical.

¿Cuáles son las opciones terapéuticas?

Los objetivos del tratamiento serán minimizar el dolor, aliviar el espasmo muscular y reestablecer una curva cervical óptima; con la finalidad de recuperar la funcionalidad plena.

Dolor agudo

La causa más común de dolor cervical son los cambios degenerativos de la columna cervical, aunque los diagnósticos diferenciales son muy extensos. Sin embargo, en pacientes que no presente sintomatología radicular, un tratamiento ini-

TABLA 5. Recomendación de rutina de ejercicios		
Flexión y extensión activa	Con las manos en el regazo. Realice flexión del cuello intentando tocar con la barbilla el pecho. Mantenga 5 segundos y vuelva al centro. Realice ahora mismo movimiento en extensión	10 repeticiones 3 series
Rotación activa y forzada	Gire la cabeza despacio hacia la derecha. Mantenga 5 segundos y vuelva al centro. Repita hacia la izquierda. Para mayor estiramiento, si el dolor lo permite se puede aplicar tensión con las puntas de los dedos en la barbilla hacia el lado deseado	10 repeticiones 3 series
Estiramiento en inclinación lateral con mano	Mirando al frente, incline la cabeza hacia la derecha, intentando que la oreja roce el hombro, sin elevar el hombro. Utiliza la mano del lado ipsilateral a la inclinación para reforzar el estiramiento aplicando presión en la sien contralateral. Mantenga 10-30 segundos. Repita hacia la izquierda	1 repetición 3 series
Estiramiento anterior de hombro manos-cintura	De pie con pies separados ligeramente más que los hombros, coloque las manos en la cintura. Dirija los codos hacia atrás; intentando aproximar las escápulas a la línea media de la columna. Mantenga durante 10-30 segundos	1 repetición 3 series
Estiramiento anterior de los hombros en pared	Colóquese en una esquina de su casa, con los hombros en abducción y los codos flexionados coloque las palmas de las manos en dos paredes diferentes; un palmo más bajo de la altura de los hombros. Deje caer el cuerpo, llevando el pecho hacia el rincón. Mantén durante 10-30 segundos	1 repetición 3 series
Elaboración propia en base a Corp et al. ¹⁵ y Monticone et al. ¹⁶ así como los ejercicios propuestos por la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación que están disponibles en: https://ejercicios.sermef.es/#/programas?zona=6343e61fd1c859edf64311c8&cuadro=6343e457d1c859edf64311b5		

cial dirigido a la causa no ha demostrado mayor beneficio al compararlo con un tratamiento sintomático no específico.

La mayoría de los dolores agudos, de leves a moderados, se resuelven aproximadamente en 3 semanas con medidas conservadoras, las lesiones causadas por latigazos cervicales ocasionan síntomas más persistentes, y precisan de intervenciones más tempranas, especialmente si está asociado con cefalea.

El mejor tratamiento es el que combine opciones no farmacológicas, especialmente ejercicio y terapia física con ayuda farmacológica¹⁵.

Ejercicio físico

El tratamiento debería comenzar facilitando información al paciente, trabajando en corregir su postura; prescribiendo una rutina de ejercicios^{15,16} (tabla 5); junto con ayuda farmacológica para control del dolor, facilitando la adherencia al tratamiento físico. La postura correcta junto al refuerzo de la musculatura reducirá la carga cervical y mejorará el dolor.

En caso de pacientes con baja adherencia al tratamiento físico, preferencia personal o con incapacidad para realizar los ejercicios, la terapia manual externa (fisioterapia) supone una opción en estos casos¹⁷.

Postura

La tendencia natural, especialmente cuando se realiza trabajo sentado, es adoptar una posición encorvada, con los hombros hacia adelante, que hay que evitar. La posición ideal sería espalda recta, totalmente apoyada en la silla, cuello alineado con columna, cabeza mínimamente flexionada. Manteniendo los hombros bajos y retraídos hacia posterior, con las escápulas aproximadas¹⁸.

Durante el sueño

La cabeza y cuello han de permanecer correctamente alineadas con el cuerpo. Boca arriba: almohada baja con los muslos ligeramente elevados apoyados en una pequeño cojín. De lado: almohada más alta para permitir la correcta alineación, piernas flexionadas con un ligero cojín separando los muslos.

Termoterapia

El calor aplicado previo a los ejercicios reduce el dolor y relaja la musculatura, permitiendo una mayor eficacia del tratamiento. Siempre debe aplicarse de forma indirecta, durante un máximo de 15 min, hasta cada 3 h si fuera necesario. Se deberían realizar los ejercicios según se tolere, a ser posible mañana y noche, o hasta 4 veces al día.

Cuando se trata de un dolor postraumatismo reciente, o se sospeche mecanismo inflamatorio, el hielo aplicado de manera similar puede ayudar en reducir la inflamación local.

Tratamiento farmacológico

La primera línea de tratamiento sería paracetamol o AINE. El objetivo del tratamiento farmacológico es reducir el malestar para que el paciente pueda realizar los ejercicios. No existen estudios de calidad que evidencien la superioridad de un fármaco frente al otro (tabla 6), por lo que la decisión terapéutica dependerá en gran medida de las características de nuestro paciente¹⁵.

Los AINE son la primera línea de tratamiento ajustando su prescripción a la correcta evaluación de los riesgos cardiovascular, gastrointestinal y renal. Deben indicarse durante el menor tiempo posible a la dosis mínima eficaz¹⁵,

TABLA 6. Resumen de la evidencia disponible para el tratamiento farmacológico del dolor de cuello

Intervención	Nº de guías	Recomendaciones por calidad de las guías		Fuerza de la recomendación	Comentario
		Alta calidad	Baja calidad		
Paracetamol	2	1 guía O+	1 guía +	Débil	
AINE	4	2 guías O+	2 guía +	Débil	Uso a corto plazo
Opioides (incluye tramadol)	2	2 guías O+		Débil	Uso a corto plazo
Fármacos para el dolor neuropático (coanalgésico)	2		1 guía ++ 1 guía +	Débil	
Fármacos tópicos	2	1 guía +	1 guía +		

+ Evidencia moderada a favor. - Evidencia moderada en contra.
 ++ Evidencia fuerte a favor -- evidencia fuerte en contra.
 O+ Opinión de expertos a favor.
 O- Opinión de expertos en contra.
 Adaptada de Corp et al.¹⁵.

favoreciendo los AINE con mejor perfil de efectos secundarios.

Para los pacientes que no puedan tomar AINE se prescribirá paracetamol 500-1000 mg hasta cada 8 h según necesite, con un dosis menor cuanto más mayor sea el paciente o si presenta insuficiencia hepática.

Los relajantes musculares¹⁹ se reservarán cuando los anteriores fármacos no sean suficientes para un buen control o a decisión del profesional cuando se considere que la afectación inicial lo precise. Intentando en todo momento evitar las benzodiacepinas y durante el menor tiempo necesario (menos de 2 semanas). Existe moderada evidencia de que el tratamiento con relajantes musculares en cuadros de cervicalgia mejora el dolor a corto plazo, pero no tiene efecto sobre la funcionalidad⁴.

- Ciclobenzaprina 5-10 mg hasta 3 veces al día según necesite.

- Tizanidina 2-4mg hasta 3 veces al día según necesite.

- Baclofeno 5-10 mg hasta 3 veces al día según necesite.

La tizanidina y el baclofeno pueden ser prescritos durante el día, intentado que la última dosis sea antes de acostarse para no interferir con el descanso nocturno. La ciclobenzaprina es particularmente sedante y se preferirá en dosis única nocturna. Las dosis dependen del peso del paciente, la edad y el riesgo de sedación.

Si los AINE/paracetamol combinados con relajantes no fueran suficientes se puede añadir tramadol a dosis bajas de 25-50 mg hasta cada 8 h, o de rescate, evitando las formulaciones retard en dolor agudo. Sin embargo, en este caso sería recomendable retirar los relajantes musculares para no aumentar el riesgo de sedación. No se recomienda utilizar las preparaciones de tramadol de liberación prolongada en un dolor agudo.

Dolor crónico

Para pacientes con riesgo de cronicidad (tabla 3) o latigazo cervical grave una recomendación temprana de terapia física podría ser beneficiosa^{20,21}.

Para pacientes con dolor persistente > 6 semanas se debería repetir la exploración, realizar pruebas de imagen, recomendar terapia física e intensificar el tratamiento no farmacológico, pilar terapéutico en dolor crónico. En pacientes con una movilidad y flexibilidad adecuada, se puede recomendar ejercicios que sean beneficiosos para el cuerpo y la mente tipo taichí, qigong, yoga o pilates; que además pueden estar combinados con terapia cognitivo conductual para mayor beneficio^{22,23}. Sin embargo, estas no son las únicas opciones y el ejercicio físico debe ser adaptado al paciente.

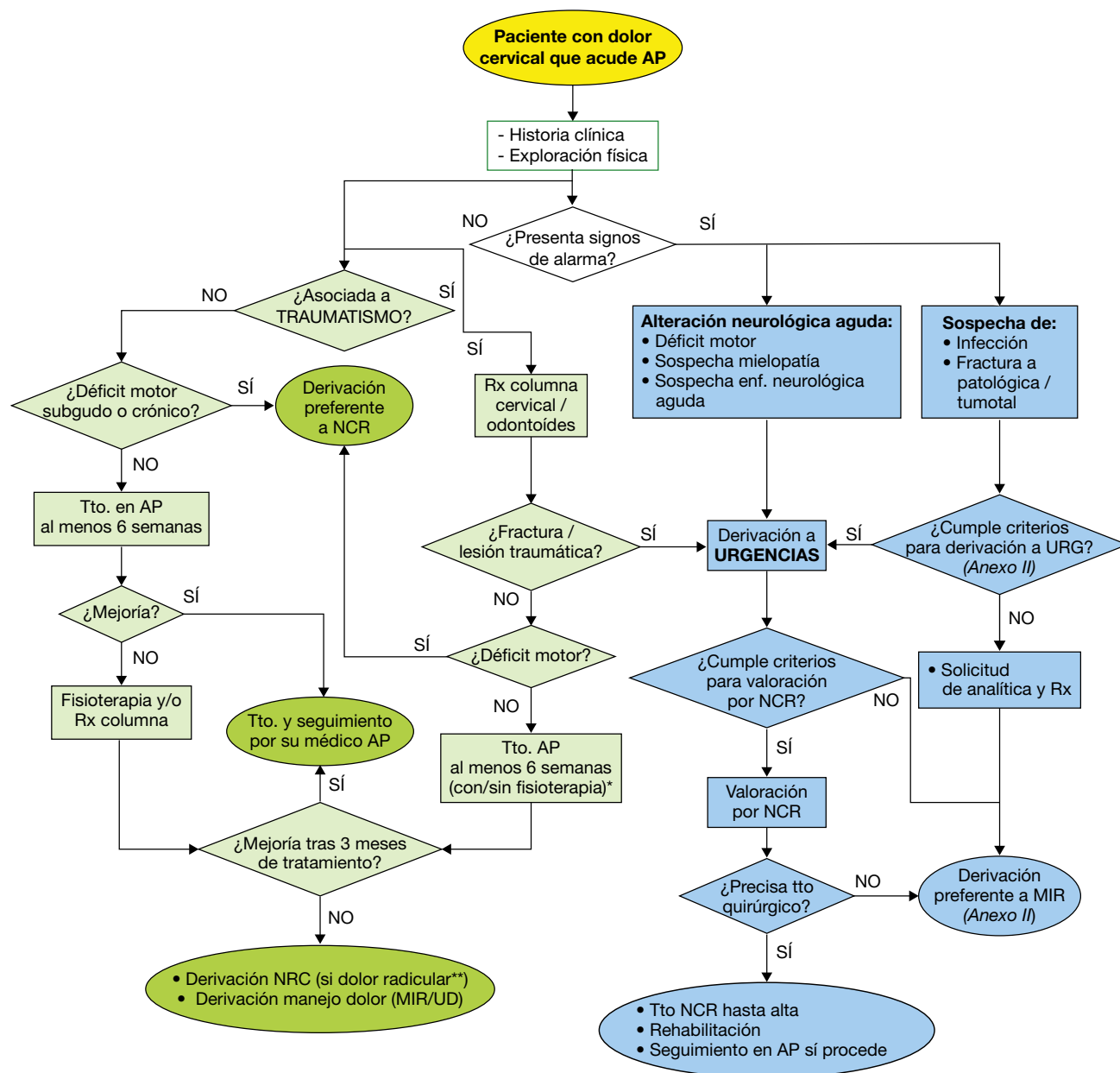
En lo que respecta al tratamiento farmacológico los AINE y los relajantes musculares no se recomiendan como tratamiento crónico. Se deben usar el menor tiempo posible, a la mínima dosis eficaz priorizando su uso en momentos de agudización. El paracetamol presenta menos riesgo en caso de uso continuado. El uso de fármacos opioides en tratamientos crónicos debería considerarse cuando otras opciones no han sido efectivas, en combinación con otras terapias, especialmente no farmacológicas y valorando adecuadamente su balance riesgo beneficio, dados sus efectos secundarios y el riesgo de abuso y dependencia. Siempre se debería de revisar el tratamiento en intervalos para intentar reducir o discontinuar según evolución.

Los fármacos coanalgésicos (antidepresivos y antiepilépticos) se recomiendan en caso de persistencia de la sintomatología. Su elección depende de los síntomas asociados y comorbilidad. Duloxetina está indicada para el tratamiento del dolor musculoesquelético crónico y su acción antidepresiva puede ayudar a pacientes con sintomatología anímica conco-

TABLA 7. Signos y síntomas de sospecha de patología radicular**Signos y síntomas de alarma en patología radicular**

- Déficit motor progresivo o severo
- Sintomatología bilateral
- Sospecha de neoplasia
- Sospecha mielopatía
- Sospecha absceso epidural

Elaboración propia.



* Los accidentes de tráfico quedan excluidos de tratamiento con fisioterapia

** Dolor radicular: Dolor tipo eléctrico o de descarga percibido por el paciente que se irradia al miembro superior siguiendo el trayecto de un nervio espinal

Figura 3. Propuesta de protocolo de derivación.

AP: atención primaria; MIR: Medicina Interna; NCR: neurocirugía; Rx: radiografía simple; Tto: tratamiento; UD: Unidad del dolor; URG: Urgencias.

Modificada de Tejedor Varillas A, et al. Proyecto Adecuación. Indicación Radiológica en patología Osteoarticular. Dasur Ap. Madrid y HU Getafe.

mitante. Si es usado con tramadol, se valorará reducir la dosis y el paciente ha de ser monitorizado ante síntomas de síndrome serotoninérgico. Los antidepresivos tricíclicos, en especial la amitriptilina o nortriptilina, pueden ser una alternativa eficaz. Se administrarán por la noche para hacer uso de su potencial sedante.

- Duloxetina 30 mg diarios, aumentando a 60 mg diarios si buena tolerancia en 2 semanas.

- Amitriptilina 10 mg diarios, por la noche, aumentando cada semana hasta una dosis de mantenimiento de 25-75 mg/24 h. No se recomienda una dosis única superior a 75 mg, en caso de precisar mayor dosis se puede administrar en dos tomas. Precaución con dosis superiores a 100 mg/24 h.

- Nortriptilina 10 mg diarios, por la noche, aumentando cada semana hasta una máxima de 50 mg diarios. Presenta mejor tolerabilidad que amitriptilina y se puede usar en ancianos o pacientes que no toleran amitriptilina.

Los fármacos antiepilépticos como gabapentina o pregabalina se usan con frecuencia, sin embargo, esta práctica no presenta evidencia suficiente para recomendarlo de manera rutinaria²⁴⁻²⁶.

Radiculopatía

En pacientes con sintomatología radicular compresiva el tratamiento no varía significativamente respecto a lo comentado hasta ahora, no existe evidencia clara de superioridad entre las diferentes opciones terapéuticas. A pesar de ello, se recomienda un tratamiento conservador con las mismas medidas que en dolor agudo, en paciente sin sintomatología de alarma (tabla 7). Es importante realizar un adecuado seguimiento y reevaluación cada 4-8 semanas.

El uso de un tratamiento corto con glucocorticoides (prednisona) a altas dosis. 60-80 mg/día durante 5 días, con posterior reducción dentro de los 5-15 días siguientes dispone de poca evidencia en cervicalgia y patología radicular²⁷.

¿Cuáles son los criterios de derivación?

Son candidatos para derivación aquellos pacientes que presentan signos de alarma, mal control del dolor a pesar de analgesia o ausencia de mejoría. En caso de presencia de síntomas de alarma valorar derivación a urgencias para descartar patología potencialmente grave y que requiera de un manejo agudo. En caso de mal control o persistencia del dolor valorar derivación a traumatología o unidad del dolor.

No existe evidencia de calidad que realice una propuesta validada de criterios de derivación por lo que la actuación debe basarse en el criterio del profesional que atiende al paciente y los protocolos locales si están disponibles. Proponemos el algoritmo anexo (fig. 3) para evaluar la necesidad de derivación.

¿Qué ha cambiado? Novedades recientes

En los últimos años la calidad y cantidad de los estudios en relación con el dolor cervical y lumbar se ha incrementado. Los objetivos de estudio se han mantenido estables durante los años. La mayoría de la evidencia actual nos ha permitido poder descartar intervenciones innecesarias o incluso perjudiciales como el sobreuso de las pruebas de imagen o el uso indiscriminado de opioides y antiepilépticos^{28,29}. Sin embargo, existe escasa novedad en cuanto a la evidencia obtenida para los tratamientos y las intervenciones positivas para el paciente. Hoy en día sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos solo tienen un efecto parcial³⁰ y que las intervenciones físicas de forma aislada (posturales y ejercicio) tienen efectos limitados³¹.

Ahora que sabemos lo que no funciona, necesitamos focalizarnos en estudios que nos aporten evidencia sobre lo que sí funciona.

Bibliografía

1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet*. 2020;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9. Erratum in: *Lancet*. 2020;396(10262):1562. PMID: 33069326; PMCID: PMC7567026.
2. WHO. ICD-11. International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics Eleventh Revision: Disponible en <https://icd.who.int/en>
3. Treede RD, Rief W, Barke A, Aziz Q, Bennett MI, Benoliel R, et al. Chronic pain as a symptom or a disease: The IASP Classification of Chronic Pain for the International Classification of Diseases (ICD-11). Vol. 160, *Pain*. 2019. p. 19-27.
4. Pérez Cajaraville J, Alonso Morales F, de la Rosa Ruiz D, González Jiménez R, Pérez Miranda A. Pautas de Actuación y Seguimiento: dolor cervical y lumbar agudo. OMC. 2022 ISBN 978-84-7867-914-0.
5. Zacharia I, Hillary R K.. Evaluation of the adult patient with neck pain. [Internet]. UpToDate. Actualizado 17/03/2021. [consultado 1 Dic 2022]. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-the-adult-patient-with-neck-pain/print?search=neck>
6. Krasin E, Schermann H, Snir N, Tudor A, Behrbalk E. A Quick and Comprehensive Guide to Differential Diagnosis of Neck and Back Pain: a Narrative Review. *SN Compr Clin Med* [Internet]. 2022;4(1). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36320816/>
7. Seoane-Mato D, Martínez Dubois C, Moreno Martínez MJ, Sánchez-Piedra C, Bustabad-Reyes S; en representación del Grupo de Trabajo del Proyecto EPISER2016. Frecuencia de consulta médica por problemas osteoarticulares en población general adulta en España. Estudio EPISER2016. *Gac Sanit*. 2019 doi: 10.1016/j.gaceta.2019.05.006. [Publicación electrónica]
8. Blanco FJ, Silva-Díaz M, Quevedo Vila V, Seoane-Mato D, Pérez Ruiz F, Juan-Mas A, et al., en representación del Grupo de Trabajo del Proyecto EPISER2016. Prevalencia de artrosis sintomática en España: Estudio EPISER2016 [published online ahead of print, 28 Apr 2020]. *Reumatol Clin*. 2020. doi:10.1016/j.reuma.2020.01.008.
9. Dieleman JL, Baral R, Birger M, Bui AL, Bulchis A, Chapin A, et al. US Spending on Personal Health Care and Public Health, 1996-2013. *JAMA*. 2016;316(24):2627-46. doi: 10.1001/jama.2016.16885. PMID: 28027366; PMCID: PMC5551483.
10. Vicente Pardo JM. La gestión de la incapacidad laboral algo más que una cuestión económica. *Med Segur Trab*. [Internet]. 2018 Jun [citado 09 Feb 2022]; 64(251):131-60. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2018000200131&lng=es.

11. Informes, Estudios e Investigación 2019. Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, 2017. Resumen ejecutivo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. NIPO en línea 731-19-046-0. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/fr/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2017/ResumenEjecutivo2017.pdf>
12. Informes, Estudios e Investigación 2020. Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, 2018. Resumen ejecutivo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2018/ResumenEjecutivo2018.pdf>
13. Hoy D, March L, Woolf A, Blyth F, Brooks P, Smith E, et al. The global burden of neck pain: estimates from the global burden of disease 2010 study. *Ann Rheum Dis*. 2014;73(7):1309-15. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204431. Publicación electrónica 30 Jan 2014. PMID: 24482302.
14. Cohen SP. Epidemiology, diagnosis, and treatment of neck pain. *Mayo Clin Proc*. 2015;90(2):284-99. doi: 10.1016/j.mayocp.2014.09.008. PMID: 25659245
15. Corp N, Mansell G, Styne S, Wynne-Jones G, Morsø L, Hill JC, et al. Evidence-based treatment recommendations for neck and low back pain across Europe: A systematic review of guidelines. *European Journal of Pain (United Kingdom)*. 2021;25(2):275-95.
16. Monticone M, Iovine R, De Sena G, Rovere G, Uliano D, Arioli G, et al. The Italian Society of Physical and Rehabilitation Medicine (SIMFER) recommendations for neck pain. *G Ital Med Lav Ergon*. 2013;35(1):36-50.
17. Walker MJ, Boyles RE, Young BA, Strunce JB, Garber MB, Whitman JM, et al. The effectiveness of manual physical therapy and exercise for mechanical neck pain: a randomized clinical trial. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2008;33(22):2371-8.
18. Grooten WJA, Mulder M, Wiktorin C. The effect of ergonomic intervention on neck/shoulder and low back pain. *Work*. 2007;28(4):313-23.
19. Peloso P, Gross A, Haines T, Trinh K, Goldsmith CH, Burnie S. Medicinal and injection therapies for mechanical neck disorders. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007;(3):CD000319.
20. Walton DM, Macdermid JC, Giorgianni AA, Mascarenhas JC, West SC, Zammit CA. Risk factors for persistent problems following acute whiplash injury: update of a systematic review and meta-analysis. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2013;43(2):31-43.
21. Schellingerhout JM, Heymans MW, Verhagen AP, Lewis M, de Vet HCW, Koes BW. Prognosis of patients with nonspecific neck pain: development and external validation of a prediction rule for persistence of complaints. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2010;35(17):E827-35.
22. Li Y, Li S, Jiang J, Yuan S. Effects of yoga on patients with chronic nonspecific neck pain: A PRISMA systematic review and meta-analysis. *Medicine*. 2019 feb;98(8):e14649.
23. Lansinger B, Larsson E, Persson LC, Carlsson JY. Qigong and exercise therapy in patients with long-term neck pain: a prospective randomized trial. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2007;32(22):2415-22.
24. Enke O, New HA, New CH, Mathieson S, McLachlan AJ, Latimer J, et al. Anticonvulsants in the treatment of low back pain and lumbar radicular pain: A systematic review and meta-analysis. *Cmaj*. 2018;190(26):E786-93.
25. Cairns R, Schaffer AL, Ryan N, Pearson SA, Buckley NA. Rising pregabalin use and misuse in Australia: trends in utilization and intentional poisonings. *Addiction [Internet]*. 2019;114(6):1026-34. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/add.14412>
26. Crossin R, Scott D, Arunogiri S, Smith K, Dietze PM, Lubman DI. Pregabalin misuse-related ambulance attendances in Victoria, 2012-2017: characteristics of patients and attendances. *Med J Aust*. 2019;210(2):75-9.
27. Ghasemi M, Masaeli A, Rezvani M, Shaygannejad V, Golabchi K, Norouzi R. Oral prednisolone in the treatment of cervical radiculopathy: A randomized placebo controlled trial. *J Research in Medical Sciences*. 2013;18(SPL. 1).
28. Dionne CE, Rossignol M, Deyo RA, Koes B, Schoene M, Battist M. Back to the Future: A Report From the 16th International Forum for Back and Neck Pain Research in Primary Care and Updated Research Agenda. *Spine (Phila Pa 1976) [Internet]*. 2022;47(19). Disponible en: https://journals.lww.com/spinejournal/Fulltext/2022/10010/Back_to_the_Future__A_Report_From_the_16th.9.aspx
29. Krebs EE, Gravely A, Nugent S, Jensen AC, DeRonne B, Goldsmith ES, et al. Effect of opioid vs nonopioid medications on pain-related function in patients with chronic back pain or hip or knee osteoarthritis pain the SPACE randomized clinical trial. *JAMA - Journal of the American Medical Association*. 2018;319(9):872-82.
30. Wong JJ, Côté P, Ameis A, Varatharajan S, Varatharajan T, Shearer HM, et al. Are non-steroidal anti-inflammatory drugs effective for the management of neck pain and associated disorders, whiplash-associated disorders, or non-specific low back pain? A systematic review of systematic reviews by the Ontario Protocol for Traffic Injur. *European Spine Journal [Internet]*. 2016;25(1):34-61. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00586-015-3891-4>
31. Hayden JA, Ellis J, Ogilvie R, Malmivaara A, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic low back pain. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2021;2021(9).